

사	술, 담배, 커피는 하시나요?/직업이 어떻게 되시나요? [스트레스] 스트레스를 많이 받으시는 편인가요? [식습관, 운동] 최근 드신 음식 중 복통의 원인이 될 만한 것이 있을까요? 평소 기름진 음식을 많이 드세요? 규칙적으로 식사 하시나요?  최근 해산물 복용 여부도 확인합니다.
가	가족 중에 소화기 질환/암을 앓으신 분이 있나요?
여	[산과] 유산하시거나 분만하신 적이 있나요? [월경] 월경은 규칙적으로 하시나요?/생리 주기는 얼마인가요?/월경량은 적당한가요?/월경통은 심하신가요? [성관계] 이걸 누구에게나 하는 질문이니 당황하지 마시고요. 최근 성관계 경험이 있으신가요?/임신 가능성이 있나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈), 공막(황달) 2. 입 : 혀(탈수), 출혈(구강 진찰 → 설암자) + 순환기/호흡기 의심 시 [목적 설명] 윗배가 아프신 분들 중 사실은 가슴이 아픈데 배가 아픈 것처럼 느낄 수 있습니다. → 심장 청진, 폐 청진 3. CVAT★ 뒤로 돌아주세요. 반드시 양쪽 다 확인, 양쪽을 한 번씩만 치는 것이 아니라 연속적으로 위에서 내려가며 여러 번 쳐준다. 4. 피부 : 손등 피부 긴장도, 하지 부종(pitting edema) [누워서] 5. 복부★ [시진] 아픈 부위를 가리켜 보세요. 기침해 보세요. (기침 시 통증, 팽만, 수술 흔적 확인) [청진] 차가우실 수 있어요(5구역, 3초씩). [타진] (아픈 부위 반대편부터 시작) 4군데, 한 군데당 2번씩 + 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간, 비장 타진/복수(shifting dullness) [촉진] (아픈 부위 마지막) Superficial 4군데, Deep 4군데 통증 있으면 반동압통 확인 + 황달 있거나 간질환 의심 시 : 간 촉진, 비장 촉진

[특이검사*] Upper : murphy, courvoisier(무통성 담낭이 만져짐)
Lower : psoas, obturator

☞ 시간이 없을 경우 murphy sign만 우선적으로 하지만, appendicitis 의심 시 psoas, rovsing, obturator sign을 하도록 합니다.

6. DRE : 직장수지검사

→ 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

- ⊕ 많이 아파했을 경우 : 자세히 보고 정확히 진찰하려다 보니 신체 검진에서 불편을 드린 것 같습니다.

STEP 2 환자 교육

공감	갑자기 배가 아파서 많이 놀라셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 ○○○로 미루어 보아 A질환이 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 상(하)복부 통증은 다양한 원인에 의해 유발될 수 있어서 그 외에 B질환, C질환도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	따라서 정확한 진단을 위해 복부 X-ray와 CT, 위내시경검사가 필요할 것으로 보입니다. 괜찮으신가요?
치료	만약 A질환이 확진되면 치료를 위해 금식 or 약물 치료 or 수술적 치료가 필요할 수 있습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다
교육	수술이 필요할지 모르니 지금부터 금식하셔야 합니다. 약을 규칙적으로 복용하고, 생활 습관을 교정하는 것이 치료에 가장 중요합니다. 술·담배는 A질환을 악화시킬 수 있기 때문에 반드시 끊어야 합니다. 또한 규칙적으로 식사를 하고 기름진 음식을 줄이는 것만으로도 A질환이 잘 조절될 수 있습니다. 배가 더 아프거나 다른 증상이 발생할 경우 언제든지 내원하세요.
질문	마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

☞ 환자가 만약 진통제를 요구한다면, 진통제에 의해 정확한 진료가 어려울 수 있으므로 원인을 찾은 후 진통제 드리겠다고 양해를 구합니다.

❖ 기본적 진단 계획

- ① 혈액검사 : CBC, LFT, amylase/lipase, 전해질검사, 소변 hCG, ESR, CRP, 분비물 배양
- ② 영상검사 : 복부 초음파검사, 복부 X-ray(ect, supine)
- ③ GERD, peptic ulcer : 위내시경
- ④ 요로 결석 : KUB, 소변검사

❖ 치료 계획

- ① Ectopic preg. : laparoscopic salpingectomy, Methotrexate
- ② 요석 : 기대요법, 체외충격파쇄석술(ESWL, Extracorporeal shock wave lithotripsy)
- ③ PID : 3세대 cepha + doxycycline
- ④ 수술 : 소화 천공 궤양, 급성 담낭염, 복부 대동맥류 파열, 급성 충수염, 요관 결석, 자궁 외 임신, 난소 꼬임 등

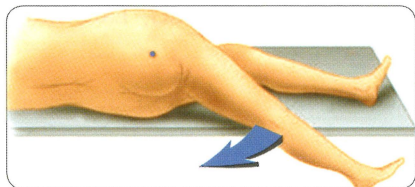
❖ 환자 안내/생활 습관 교육★

- ① 정확한 진단/치료 위해 입원이 필요할 수 있음을 설명
- ② 원인에 따른 치료 원칙 설명(특히 수술하는 경우 잘 설명)
- ③ 가임기 여성의 경우 급성 복통의 원인이 소화기계 또는 생식기계 등으로 다양할 수 있음을 설명하고 응급 상황인 경우 수술이 필요함을 교육함
- ④ 흡연은 자궁 외 임신의 위험 인자로 금연 교육이 필요, 골반 내 감염도 자궁 외 임신율을 높이므로 안전한 성관계 가질 것을 교육해야 함
- ⑤ 자궁 외 임신의 가장 흔한 합병증으로 지속적 자궁 외 임신이 가능하므로 복부 통증, 무월경, 질출혈 지속 시 다시 내원할 것 교육
- ⑥ 급성 췌장염 : 금식, 수액, NG tube(ileus 있으면), 진통제(morphine 계열)



keyword

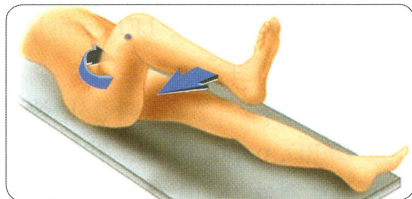
비뇨 생식계/순환 호흡계/여성의 경우 산과 질환 감별 진단하기
진통제는 진찰/진단 후 처방 가능성을 알리기
복부 진찰 시 항상 다리를 굽혀달라고 먼저 요청하기
응급 조치 및 수술이 필요한 경우 교육 파트에서 필요성 잘 설명하기
수술이 필요한 경우 금식도 교육하기



[Psoas 징후]

오른쪽 허벅지를 펴(신전)할 때 통증이 있음
(충수돌기가 후복막에 위치한 경우)

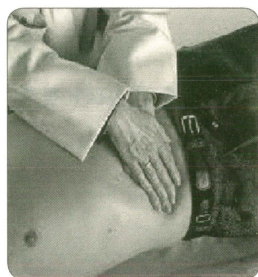
→ 급성 충수돌기염



[Obturator 징후]

오른쪽 허벅지를 안쪽 돌림(내회전)시킬 때
통증이 있음(충수돌기가 골반쪽에 있을 때)

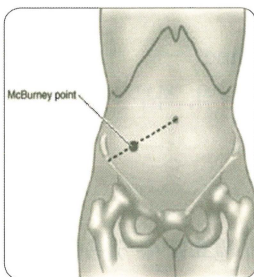
→ 급성 충수돌기염



[Rovsing 징후]

왼쪽 아랫배를 촉진했을 때
오른쪽 아랫배에 통증이 발생

→ 급성 충수돌기염



[McBurney 징후]

오른쪽 아랫배(ASIS와 배꼽의
중간)의 통증

→ 급성 충수돌기염



[Murphy 징후]

오른쪽 윗배의 갈비뼈 아래 경계 부위를
가볍게 누른 상태에서 숨을 깊게 들이
마시면 갑자기 통증이 유발

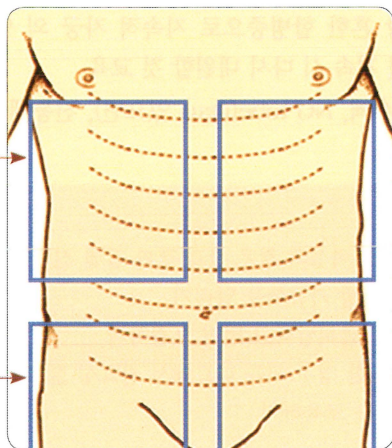
→ 급성 담낭염

우상복부 통증

- 간, 담도계 질환
- 췌장염
- 폐렴

우하복부 통증

- 충수돌기염
- 장폐쇄
- 개실염
- 자궁 외 임신
- 난소, 나팔관 질환
- 자궁내막증
- 요로 결석



좌상복부 통증

- 위염, 위궤양
- 췌장염
- 비장 질환
- 심근경색, 폐렴

좌하복부 통증

- 개실염
- 장폐쇄(대장)
- 자궁 외 임신
- 난소, 나팔관 질환
- 자궁내막증
- 요로 결석

시험 관련 코멘트



소화불량/만성 복통의 경우 복통과 함께 나타나거나 단독 증상으로 흔히 발생할 수 있습니다. 기능성/기질적/그 외(약물 복용 등) 원인을 감별하는 것이 중요하

며, 병력 청취와 신체 진찰에서 감별 진단을 시행할 수 있어야 합니다. 소화불량의 기질적 원인으로는 신생물, 소화성 궤양/역류 질환, 위, 간담체의 염증/허혈, 위장자 운동 이상 등을 고려해야 합니다.

병력 청취 시 증상이 **위와 관련된 경우 커피, NSAIDs, 항생제 복용 과거력**을 물어보는 것이 좋습니다. 평소 식습관이 소화불량과 밀접한 관련이 있으므로 사회력에서 물어보아야 합니다. 악화/완화 요인에서 원인 질환에 따른 위험 요인 외에도 공복 시/식후 소화불량이 심해지는지를 물어본다면 진단 범위를 좁혀 갈 수 있습니다. 소화불량의 경우 **과거 소화기 병력을 확인**하는 것이 중요합니다. 그동안 건강 검진에서 상부 위장관내시경, 대장내시경을 받은 적이 있는지, 이상 소견은 없었는지 역시 확인해야 합니다. 원인 질환을 감별하기 어렵다면 기본으로 **기능성 소화불량 가능성을 염두**하는 것이 좋습니다.

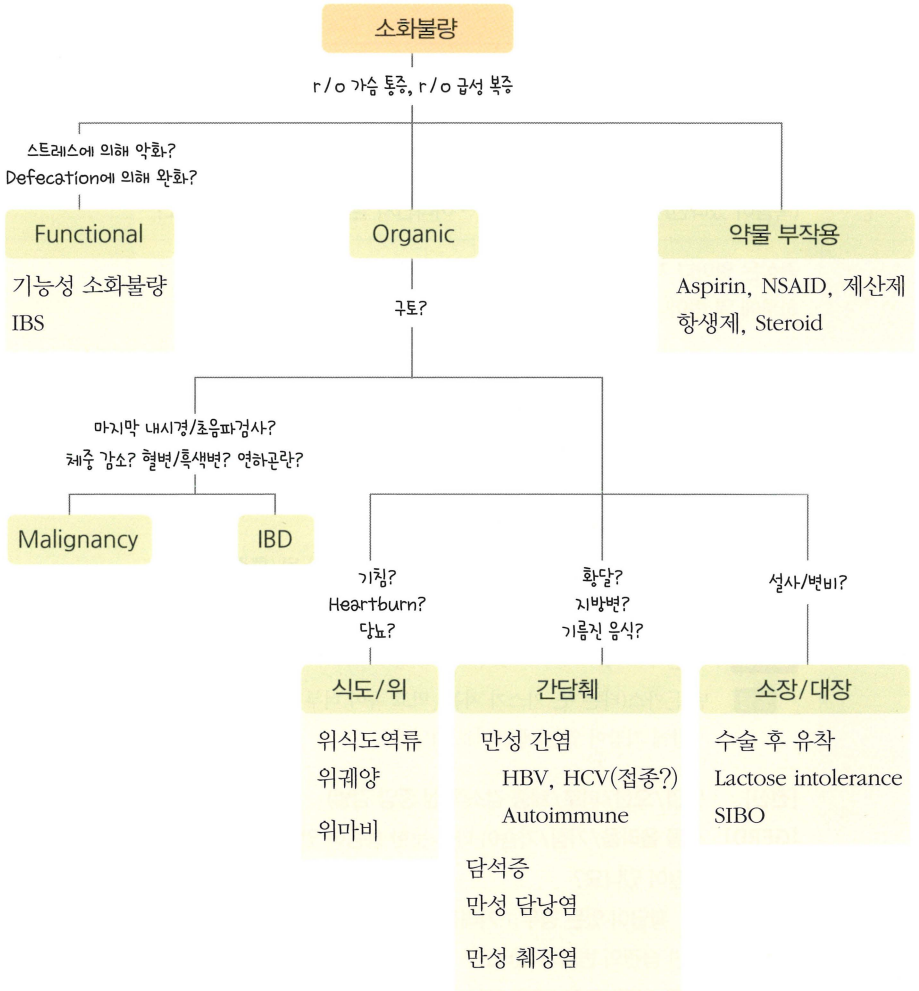
신체 진찰의 경우 소화불량 항목은 황달과 탈수를 확인하고, 림프절을 촉진하고, 복부 진찰(필요 시 Murphy's sign도) 진행해야 합니다.

환자 교육에서 **금주, 금연 뿐만 아니라** 카페인인 경우 위산 분비를 촉진하고 식도조임근을 이완시키기 때문에 **커피를 줄이는 것**에 대한 교육도 필요합니다.

질병별 진단 / 치료 계획 정리

계통	원인	질병	진단 키워드	검사/치료
위 / 소장	미란 / 궤양	위식도역류병 (GERD)	[병력] 명치 부위에 타는 듯한 통증, 식후/누울 때 악화, 제산제 복용 시 완화 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 24시간 식도 pH검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, 생활 습관 교정
		위염★ / 위궤양★ / 십이지장궤양★	[병력] 속쓰림, 식후에 악화(위궤양), 공복 시 악화(십이지장궤양), 명치부 통증 [검진] 상복부 압통 있을 수 있음	[검사] 위내시경, 요소날숨검사, 신속요소분해효소검사 [치료] 양성자펌프억제제, 제산제, <i>H. pylori</i> 제균 치료

위 / 소장	종양	위암★ (gastric cancer)	[병력] 체중 감소, 소화불량, 흑색변, 이전 위내시경에서 궤양 소견 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 위내시경, 복부 CT [치료] 위절제술, 내시경점막절제술, 항암 치료
	마비	당뇨병 위마비 (diabetic gastroparesis)	[병력] 오래된 당뇨 병력/ 복부 팽만감/음식 구토/ 상복부 불편감/식후 속쓰림 [검진] 특이 소견 없음	[검사] 혈중 포도당, 당화혈색소, 위배출검사 [치료] 당뇨 조절, Metoclopramide, Cisapride
간 담 체계	담	담석증★ (cholelithiasis) 만성 담낭염★ (chronic chole cystitis)	[병력] 담석 진단, RUQ 통증, 오심, 구토 [검진] RUQ 압통 있을 수	[검사] 상복부초음파, LFT [치료] 쓸개절제술
	췌	만성 췌장염 (chronic pancreatitis)	[병력] 심와부 통증, 제산제 복용 후에도 완화 안 됨, 음주 후 악화, 지방변 [검진] 심와부 통증, 등으로 뻐치는 통증	[검사] 복부초음파, 복부 CT, 복부 MRI, 내시경역행담췌관조영 [치료] 췌장효소 보충, 금주/금연, 식이 조절(과식, 고지방식 자제), 통증 조절
	간	만성 간염 (chronic hepatitis)	[병력] 피로, 식욕 저하, 구역, 구토, 근육통, 소변색 진해진, 황달 [검진] 간비대될 수 있으나 확인은 어렵다.	[검사] HBsAg, anti-HAV, anti-HCV, LFT [치료] 항바이러스제, 보존적 치료
기타		젖당불내성★ (lactose intolerance)	[병력] 우유 마시면 속이 불편함, 묽은변 [검진] 이상 소견 없음	[검사] 수소날숨검사, 젖당부하검사 [치료] 유당회피요법
		과민대장증후군★ (IBS)	[병력] 젊은 여성/만성적 복통/ 배변 후 완화/배변 습관 및 양상 변화/복부 팽만/잦은 트림 및 방귀/소화불량/ 스트레스 시 악화 [검진] 경미한 복통	[검사] 대변검사, 대장내시경, CBC [치료] 심리적 안정, 적당한 운동과 휴식, 식습관 교정(고섬유, low FODMAP, 술/커피 줄이기), 진경제, 완하제
		기능 소화불량★ (functional dyspepsia)	[병력] 상복부 통증/쓰림, 식후 충만감, 조기 포만감, 불규칙한 식습관 및 생활 습관/ 스트레스/내시경 정상 [검진] 대체로 정상, 상복부 압통	[검사] 원칙적으로 필요 없으나 위내시경, 신속요소분해효소검사 등으로 다른 질환 감별 [치료] 양성자펌프억제제(궤양형), 운동 촉진 약물(운동장애형)



STEP 1 병력 청취

O	언제부터 속이 쓰렸나요? → 소화가 안됐나요? 갑자기 그러신 건가요?/아니면 서서히 속쓰림이 나타났나요? 하루 중 언제 주로 그런 것 같으세요?
L	(복통이 있다면) 위치는 어디인가요? → 어디인지 짚어주실 수 있으신가요?
D	증상은 얼마나 지속되나요? 하루에 몇 번이나 증상을 느끼시나요?
Co	점점 심해지나요?
Ex	이전에도 비슷한 증상이 있으셨나요? 당시 치료는 받으셨나요?
C	[양상] 속이 어떻게 불편하신가요? (타는 듯/속이 더부룩/가스 차는 느낌/소화가 안 됨/통증) [정도] 증상이 얼마나 심하신가요? (일상 생활에 지장을 받으시나요?/NRS) 암기법 탄 돈가스 먹고 속이 더부룩해져서 일지에 쓰기로 하였다. 설명 탄 돈가스(타는 듯, 가스가 차는) 먹고 속이 더부룩해져서(속이 더부룩한) 일지(일상 생활에 지장이 있는)에 쓰기로 하였다.
A	[전신] 발열/오한/피로/체중 감소(악성 종양 감별) [GERD] 신물 올라옴/기침/가슴이 타는 듯한 통증이 있나요? [간담체] 황달이 있나요? + 황달이 있는 경우 : 가려움, 복수, 소변색/대변색 변화 [IBS] 배변 습관의 변화가 있나요? [소화기] 식욕 저하/구역/구토/설사/변비/혈변/흑색변/복통/속쓰림/복부 팽만/삼킬 때 어려움(연하곤란)이 있나요? 암기법 연신 물배만 채우는 습관은 곤란하다. 설명 연신 물(신물이 올라옴)배만 채우는 습관(배변 습관의 변화)은 곤란하다(연하곤란). [정신] 우울, 불안